

■ 整形外科／術後回復

大腿骨骨折術後の睡眠障害、1か月88.2%から13か月27.8%へ

バーセル指数との関連は多変量調整後も有意 323人の前向きコホート

PSD の割合は1か月時88.2%から13か月時27.8%へ低下し、負担は1か月時が最大だった(平均PSQI 7.72)。PSQIは有意に改善し(β =-0.151、95%CI -0.188～-0.114、 $p<0.001$)、BIは上昇した(β =3.041、95%CI 2.701～3.380、 $p<0.001$)。

PSQIが高いほどBIは低く、多変量調整後も関連は残った(β =-0.014、95%CI -0.023～-0.005、 $p=0.002$)。性別と時間の交互作用があり、男性は女性より睡眠の回復が遅い傾向だった($p=0.013$)。

後ろ向きの相関解析で心理的要因など残余交絡は否定できない。著者らは睡眠障害をスクリーニ

ングしやすく介入可能な因子と位置づけ、術後リハへの睡眠評価の組み込みと、的を絞った介入の検証を今後の課題に挙げている。



術後リハに、睡眠のスクリーニングを組み込む視点

出典 **Orthopaedic Surgery** ↗

数字で見る

323人

対象患者(前向きコホート・最長13か月追跡)

88.2→27.8%

術後睡眠障害(PSD)の割合、1か月時→13か月時

1.226倍

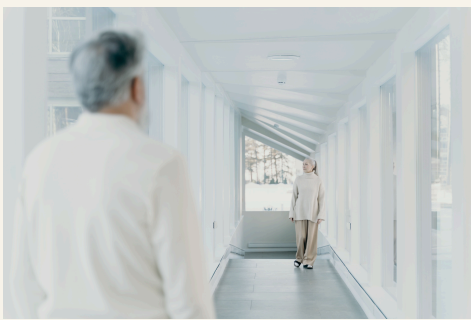
術前ACCI(併存疾患)高値の1か月PSDへの影響(調整OR)

■ 老年医学／予後予測

90歳以上502人、歩行速度0.21m/s速いと死亡リスク20%減、95歳以上では関連消失

平均歩行速度は0.55m/s、追跡中259人が死亡。年齢層による差(交互作用 $p=0.01$)以外、性別・人種民族・歩行補助具の有無による差はなかった。

簡便な歩行速度テストは90～94歳では死亡リスクを見分ける臨床ツールになりうるが、95歳以上



では速度だけで予後を語れない可能性がある。

出典 **J Am Geriatrics Soc** ↗

■ FIM／退院支援

退院時FIM認知5項目、974人の解析で「理解↔表出」「記憶↔問題解決」が強く関連

中心性が最も高かったのは理解で、ブートストラップの安定性も良好(CS係数0.677)。後ろ向きの記述研究で、著者らは退院計画時の探索的な枠組みとしつつ、因果関係や介入対象を示すものでは



ないと注意している。

出典 **Disabil Rehabil** ↗

短 信

〈脳卒中／VR〉MT先行+ARで運動・感覚がより改善

77人3群RCT。MT+AR群はMCID達成割合が3群中最高、効果は3か月後も持続 出典 [Am J Occup Ther](#) ↗

〈脊髄損傷〉rTMS併用のOTで上肢機能が改善

頸髄損傷29人RCT。GRASSP等でrTMS+OT群が優位、痛み・抑うつは両群で悪化 出典 [Spinal Cord](#) ↗

〈心臓リハビリ〉心リハ患者のVO2peak基準値を提示

1,651人。VO2peak1単位でMACE男性7%・女性5%減、最高四分位は55%減 出典 [Eur J Prev Cardiol](#) ↗

〈呼吸リハビリ〉COVID後の活動量質問票を検証

752人。低活動の特異度88.4%・感度26.3%、加速度計との併用を推奨 出典 [ERJ Open Res](#) ↗

〈せん妄〉専門医紹介を要したせん妄の関連因子

入院患者20,980人。認知症OR3.995・せん妄既往OR3.649・大量飲酒OR1.648 出典 [PCN Reports](#) ↗

〈理学療法評価〉ICF中核セット34項目、一次医療で妥当性確認

スペイン47施設・387組。全項目が保持基準超、患者-PT間ICC0.697～0.958 出典 [Frontiers Rehabil Sci](#) ↗

〈病棟運営〉看護師の勤務時間の18%が事務・物流

ベルギー3,613人調査。負担が大きいほど不満・ケア残しと関連 出典 [J Nurs Manag](#) ↗

〈疼痛管理〉TKA後の遷延痛、患者の語りを統合

質的研究8件の統合。身体化の喪失・医療者との断絶などが影響 出典 [Disabil Rehabil](#) ↗